

Política de tratamiento de datos y aviso de privacidad

Política | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Definir tratamiento proporcional de datos personales y sensibles con finalidades, derechos y canales reales.

2. Alcance y condiciones de uso

Base de política para completar responsable, domicilio y canales antes de adoptar. Salud e imágenes identificables reciben control reforzado. La atención de urgencia u otras bases legales no se confunden con permisos comerciales.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Autor de la atención	Registrar de manera oportuna, íntegra y autenticada.
Custodio	Controlar acceso, conservación, entrega y recuperación.
Apoyo administrativo	Acceder solo a datos necesarios según permiso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Completar responsable y canales de consulta, reclamo y protección de derechos

Completar responsable y canales de consulta, reclamo y protección de derechos. Inventariar historia, agenda, facturación, imágenes, contactos, proveedores y respaldos con finalidad y acceso.

2. Definir bases jurídicas y autorizaciones requeridas según cada finalidad

Definir bases jurídicas y autorizaciones requeridas según cada finalidad. Informar carácter sensible y derechos; no condicionar atención a publicidad, fotos comerciales o consentimiento innecesario.

3. Separar autorización asistencial, datos administrativos, uso clínico de imagen y uso públi

Separar autorización asistencial, datos administrativos, uso clínico de imagen y uso público o comercial. Una fotografía clínica no implica permiso para redes sociales y un consentimiento terapéutico no autoriza cualquier tratamiento de datos.

4. Implementar medidas de acceso por rol, confidencialidad de personal y contrato con encarga

Implementar medidas de acceso por rol, confidencialidad de personal y contrato con encargados de tratamiento, incluyendo software y nube cuando existen. Verificar ubicación, riesgos y medidas sin prometer seguridad absoluta.

5. Atender solicitudes verificando identidad y legitimación, registrando fecha y plazo según

Atender solicitudes verificando identidad y legitimación, registrando fecha y plazo según regulación. Preservar obligaciones de conservación de historia y explicar cuando una supresión no procede por deber legal.

6. Mantener aviso breve con finalidades, responsable y acceso a política completa

Mantener aviso breve con finalidades, responsable y acceso a política completa. Revisar cambios, incidentes y transferencia o transmisión, documentar acciones y comunicar lo que la normativa requiera.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Datos mínimos y finalidades específicas.

Canales reales antes de publicar.

Autorizaciones opcionales separadas.

La reserva clínica no se levanta por tener un aviso de privacidad.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.6 y 11.3.1.27-28: historia y registros; Resoluciones 1995/1999, 839/2017, Ley 1581/2012 y consentimiento conforme a Ley 528/1999 y reglas particulares.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Responsable y canal	
Base de datos	
Datos tratados	
Finalidad	
Base y autorización	
Encargado y acceso	
Conservación	
Solicitud y legitimación	
Respuesta y fecha	
Incidente y medida	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Datos sensibles

Ley 1581 de 2012, artículos 4-6, 8-12 y 17-18; Decreto 1074 de 2015, reglas de tratamiento. Información de salud y finalidades opcionales requieren análisis de base jurídica, autorización cuando exigible y seguridad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Historia clínica

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autoría, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576